

PUBMED DAILY WATCH • 2026-06-14

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文献 监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-08 至 2026-06-14。每篇文章单独 1 页 slide，并明确区分已验证证据、论文作者观点和我的推断；本页只做文献监测和研究设计启示，不提供医疗建议。

EDAT 新入库

50

PDAT 发表日期

32

MDAT 记录更新

280

精选文献

10

下载 PDF

下载 PPTX

固定公网链接

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-14 检索；窗口为 2026-06-08 至 2026-06-14，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。官方计数为 EDAT 50、PDAT 32、MDAT 280，去重候选池 284 条。本日按 10 papers/day 和 pubmed-history.json 去重，选择 10 篇未跨日重复 PMID；其中 40450180 为 MDAT 记录更新且原始发表不在近 7 天，纳入原因是 CNSL/BTKi 治疗相关性高，已在对应页明确标注。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

#	方向	疾病	PMID	标题
1	双抗 / CD3xCD20 / 一线化疗减量或去化疗探索	新诊断 CD20 阳性 large B-cell lymphoma / DLBCL，老年且不适合环磷治疗	42285113	EPCORE DLBCL-3: epcoritamab 单药一线用于不能接受受环磷方案的老年 DLBCL
2	CAR-T / bridging therapy / 真实世界多中心队列	复发/难治 large B-cell lymphoma	42285354	CAR-T 前桥接反应比桥接方案类型更能预测 LBCL 结局
3	CAR-T / 安全性 / 患者报告结局	侵袭性 B 细胞淋巴瘤，主要为 DLBCL	42285114	CAR-T 后早期症状负担：患者报告 AE 明显补足医生评估
4	CNS 预防 / DLBCL / 观点社论	高 CNS 复发风险 DLBCL / LBCL	42274643	JCO 社论：DLBCL 中 CNS 预防是否应结束 HD-MTX 惯性使用
5	新诊断 DLBCL / 治疗综述 / 早线策略	新诊断 diffuse large B-cell lymphoma	42286378	新诊断 DLBCL 治疗策略综述：从 pola-R-CHP 到双抗/CAR-T 前移
6	R/R LBCL / CAR-T / 双抗 / ADC / 证据框架	复发/难治 large B-cell lymphoma	41871044	R/R LBCL 证据蓝图：CAR-T、双抗、ADC 和下一代组合的排序难题
7	DEL / 系统综述 / BTKi 与 BCL2 靶向联合	MYC/BCL2 double-expressor DLBCL	42255243	Double-expressor DLBCL 系统综述：DEL 风险量化与 Z+R-CHOP / Ven-R-CHOP 信号
8	分子分型 / MYD88 / ABC DLBCL	DLBCL，特别是 non-GCB / ABC 亚型和结外部位	42257713	MYD88 L265P：非 GCB/ABC DLBCL 的高特异性分子标志
9	机制研究 / 免疫微环境 / 耐药与免疫抑制	DLBCL	42269122	DLBCL 肿瘤来源 EV 通过巨噬细胞诱导 MDSC 积累和 T 细胞抑制
10	CNSL / BTKi / orelabrutinib / 回顾研究	原发或继发中枢神经系统 DLBCL	40450180	CNSL 治疗 MDAT 更新：orelabrutinib + rituximab + HD-MTX 回顾研究

EPCORE DLBCL-3: epcoritamab 单药一线用于不能接受蒽环方案的老年 DLBCL

Epcoritamab monotherapy or epcoritamab with lenalidomide as first-line therapy for patients with diffuse large B-cell lymphoma (EPCORE DLBCL-3): primary analysis of an open-label, multicentre, randomised, phase 2 trial.

PMID 42285113

打开 PubMed

双抗 / CD3xCD20 / 一线化疗减量或去化疗探索

新诊断 CD20 阳性 large B-cell lymphoma / DLBCL，老年且不适合蒽环治疗

EDAT/PDAT/MDAT 命中；2026-06-12 发表，近 7 天新增

P 人群

不适合蒽环方案的新诊断 CD20 阳性 large B-cell lymphoma / DLBCL 老年患者

I 干预/暴露

固定疗程皮下 epcoritamab 单药或 epcoritamab+lenalidomide

C 比较

随机 II 期阶段 1 比较单药与联合；阶段 2 扩展单药

O 结局

CR 率、3 级及以上 AE、严重 AE、治疗相关死亡和感染风险

结论

这项开放标签、多中心、随机 II 期研究纳入不适合蒽环化疗的高龄新诊断 DLBCL 患者。阶段 1 中，epcoritamab 单药 CR 率为 63.6%，epcoritamab+lenalidomide 为 45.5%；因疗效和安全性差异，研究选择单药进入扩展阶段。跨阶段 epcoritamab 单药 CR 率为 57.6%，但严重不良事件和感染仍需要重点监测。

主要内容

- 研究对象为新诊断、CD20 阳性、II-IV 期 large B-cell lymphoma，年龄通常在 75-80 岁以上且不适合蒽环方案。
- 干预为固定疗程皮下 epcoritamab，比较 epcoritamab 单药和 epcoritamab+lenalidomide；主要终点为 Lugano 标准下研究者评估 CR 率。
- 阶段 1 中单药 CR 28/44，联合组 CR 20/44；扩展后单药总体 CR 38/66。
- 3 级及以上 AE 中，单药组常见感染、疲乏、高血压；联合组中性粒细胞减少和感染更突出。

关键信息

- 作者：Umberto Vitolo、Juan Miguel Bergua Burgues、Johannes Duell、Michal Kwiatek、David Belada、Wojciech Jurczak 等。
- 核心数据：单药跨阶段 CR 57.6%；阶段 1 单药 CR 高于联合组，安全性也更可控。
- 研究价值：把 CD3xCD20 双抗前移到一线老年/合并症人群，是化疗不耐受 DLBCL 的重要早期信号。
- 方向标签：epcoritamab、CD3xCD20、anthracycline-free、frontline DLBCL、older adults。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确报告研究设计、108 例治疗人群、CR 率、安全性事件和研究选择 epcoritamab 单药进入扩展阶段。

论文作者观点

论文作者观点：固定疗程 epcoritamab 单药在高龄且不适合蒽环方案的新诊断 DLBCL 中显示有前景的 CR 率和可管理安全性，值得继续研究。

我的推断

我的推断：一线双抗研究应把年龄、合并症、感染风险和治疗负担作为并列变量，而不能只看 CR。当前结果仍是 II 期信号，不应写成一线标准替代方案。

CAR-T 前桥接反应比桥接方案类型更能预测 LBCL 结局

Impact of Bridging Response on Outcomes After CD19 CAR T-Cell Therapy in Large B-Cell Lymphoma.

PMID 42285354

打开 PubMed

CAR-T / bridging therapy / 真实世界多中心队列

复发/难治 large B-cell lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 命中; 2026-06-12 发表, 近 7 天新增

人群

接受商业化 CD19 CAR-T 的 R/R LBCL 成人患者

干预/暴露

制造期桥接治疗并按桥接反应分层

比较

桥接后 CR/PR vs SD/PD; 不同桥接治疗类型

结局

CAR-T 后 PFS、OS、CRS、ICANS 和严重血液学毒性

结论

这项多中心真实世界回顾研究纳入 377 例接受商业化 CD19 CAR-T 的 R/R LBCL 患者，其中 248 例接受桥接治疗。桥接后达到 CR/PR 的患者，CAR-T 后 PFS 和 OS 显著优于 SD/PD；多变量模型中，桥接反应仍独立预测 PFS 和 OS，而桥接方案类型本身不是独立生存因素。

主要内容

- 桥接治疗发生在 CAR-T 制备期间，产品包括 axi-cel、tisa-cel 和 liso-cel。
- 桥接治疗组输注前 ORR 为 49%，CR 为 12%。
- 与 CR 相比，SD/PD 的 PFS 风险 HR 2.59，OS 风险 HR 4.53。
- 桥接反应类别与 CRS/ICANS 发生率无显著差异；强化化疗桥接更常见严重血液学毒性。

关键信息

- 作者：Beatriz Wills、Sarah Samorodnitsky、Samantha Brown、Jessica R Flynn、Sean Devlin、Michael Scordo 等。
- 核心判断：桥接治疗的目标不只是等待制造完成，而是尽量降低输注前肿瘤负荷和炎症状态。
- 研究设计价值：比较 response to bridging 与 modality，比单纯罗列桥接方案更接近 CAR-T 前管理问题。
- 方向标签：CD19 CAR-T、bridging response、tumor burden、PFS、OS、real-world LBCL。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确报告 377 例队列、248 例桥接治疗、桥接 ORR/CR、PFS/OS HR，以及 CRS/ICANS 与血液学毒性观察。

论文作者观点

论文作者观点：桥接反应而非桥接方案类别与 CAR-T 后生存更强相关，支持以有效控病和毒性平衡为核心设计桥接策略。

我的推断

我的推断：CAR-T 研究可把输注前反应、LDH、炎症指标和肿瘤负荷作为分层或校正变量。该研究不能证明某一种桥接方案最优。

CAR-T 后早期症状负担：患者报告 AE 明显补足医生评估

Real-world patient-reported symptomatic adverse events and concordance with physician assessments after CAR T-cell therapy in patients with aggressive B-cell lymphomas: a prospective study.

PMID 42285114

打开 PubMed

CAR-T / 安全性 / 患者报告结局

侵袭性 B 细胞淋巴瘤，主要为 DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中；2026-06-12 发表，近 7 天新增

人群

接受 CAR-T 的侵袭性 B 细胞淋巴瘤成人患者

干预/暴露

第 10 天 PRO-CTCAE 患者报告症状评估

比较

患者报告 AE 与医生 CTCAE 评估的一致性

结局

短期症状发生率、中重度症状、医生低报比例和症状负担预测因素

结论

这项意大利 13 中心前瞻性观察研究在 CAR-T 后第 10 天用 PRO-CTCAE 评估症状。143 例完成量表者中，疲乏、食欲下降、失眠、寒战、腹泻等症状非常常见；医生对多种症状存在低报，尤其是吞咽困难、食欲下降、恶心和腹泻。研究强调 CAR-T 支持治疗需要系统纳入患者报告结局。

主要内容

- 170 例入组，主要诊断为 DLBCL 118 例；CAR-T 产品包括 axi-cel、tisa-cel 和 brexu-cel。
- 第 10 天任何级别症状中，疲乏 87%、食欲下降 83%、失眠 79%、寒战 73%、腹泻 70%。
- 中重度症状中，疲乏 55%、食欲下降 53%、腹泻 45%、寒战 35%、失眠 31%。
- 医生评估低报多项症状，提示传统 AE 记录不能完全反映短期治疗负担。

关键信息

- 作者：Fabio Efficace、Pier Luigi Zinzani、Francesca Bonifazi、Ilaria Cutini、Barbara Botto、Annalisa Chiappella 等。
- 核心数据：第 10 天 12/19 个症状任何级别发生率超过 50%。
- 支持治疗启示：CAR-T 后安全性监测不应只关注 CRS/ICANS，也要记录患者主观症状和生活影响。
- 方向标签：CAR-T、PRO-CTCAE、supportive care、aggressive B-cell lymphoma、symptom burden。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确报告研究对象、PRO-CTCAE 时间点、常见症状比例、医生低报现象和研究结论。

论文作者观点

论文作者观点：系统使用患者报告结局能为 CAR-T 后早期支持治疗提供补充信息，改善症状识别和干预时机。

我的推断

我的推断：未来 CAR-T 队列可把 day 10 或 day 14 PRO 作为毒性负担终点，与住院时长、再入院和感染风险一起分析。该研究不改变 CAR-T 适应证。

JCO 社论：DLBCL 中 CNS 预防是否应结束 HD-MTX 惯性使用

End of Methotrexate for CNS Prophylaxis in Diffuse Large B-Cell Lymphoma.

PMID 42274643

打开 PubMed

CNS 预防 / DLBCL / 观点社论 高 CNS 复发风险 DLBCL / LBCL EDAT/PDAT/MDAT 命中; 2026-06-11 发表, 近 7 天新增; 社论无摘要

P 人群

DLBCL 中被认为存在 CNS 复发风险的患者群体

I 干预/暴露

甲氨蝶呤 CNS prophylaxis 作为被讨论策略

C 比较

社论性质, PubMed 摘要未提供具体比较

O 结局

证据再评价信号; 非原创临床疗效数据

结论

这篇 JCO 社论题名直接回应 DLBCL 中甲氨蝶呤 CNS 预防的证据转折。PubMed 记录没有摘要, 因此本页只把它作为与同期 JCO 超高危 LBCL CNS 预防研究相关的专家观点信号, 而不补写未验证的社论细节。它的价值在于提示: CNS 预防研究正在从习惯性 HD-MTX 使用转向更严格的风险分层、结局验证和毒性权衡。

主要内容

- 文章类型为 Editorial, PubMed 未提供摘要, 不能从记录中确认作者具体论证路径。
- 题名指向 DLBCL 中 CNS prophylaxis 的核心争议: 既往甲氨蝶呤预防策略是否仍有足够证据支持。
- 本条与 2026-06-12 已监测到的 JCO 超高危 LBCL HD-MTX CNS 预防研究构成同一证据讨论链。
- 作为每日监测条目, 它代表 CNS 预防策略从经验性预防向证据再评价的信号。

关键信息

- 作者: Jonathan W Friedberg。
- 证据边界: 无摘要, 只能引用题名、期刊、文章类型、PMID 和发表日期。
- 为什么纳入: 今天 10 篇中需要保留 CNS 预防方向, 而且这是近 7 天 DLBCL/CNS 预防最直接的新 PubMed 记录。
- 方向标签: CNS prophylaxis、methotrexate、DLBCL、editorial、evidence reassessment。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 记录确认题名、作者、JCO、Editorial 类型、2026-06-11 发表和 PMID。

论文作者观点

论文作者观点: 从题名可确认作者认为 DLBCL 中甲氨蝶呤 CNS 预防正面临终结性再评价; 具体论点因 PubMed 无摘要, 未在本页展开。

我的推断

我的推断: 后续 CNS 预防研究应优先设计可验证的高危人群、CNS 复发终点和毒性/延误治疗终点。不能仅凭社论题名得出临床停用结论。

新诊断 DLBCL 治疗策略综述：从 pola-R-CHP 到双抗/CAR-T 前移

Emerging treatment strategies for newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma.

PMID 42286378

打开 PubMed

新诊断 DLBCL / 治疗综述 / 早线策略

新诊断 diffuse large B-cell lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 命中；2026-06-12 发表，近 7 天新增

P 人群

新诊断 DLBCL 患者，特别是高危和分子亚型人群

I 干预/暴露

pola-R-CHP、靶向药、抗体药物、CAR-T 和 CD20xCD3 双抗前移

C 比较

传统 R-CHOP 基线和分子分层策略

O 结局

早线疗效、复发风险降低、毒性和未来临床试验设计方向

结论

这篇综述梳理新诊断 DLBCL 的治疗演进：R-CHOP 仍是长期基石，pola-R-CHP 已成为新的治疗选项之一；针对信号通路、细胞抗原、表观遗传调控和分子亚型的策略正在推进。复发/难治阶段有效的 tafasitamab、golcadomide、CAR-T 和 CD20xCD3 双抗，也在被评估是否可前移到早线。

主要内容

- 综述指出约 40% DLBCL 患者结局仍不理想，尤其是高危生物学或一线治疗失败人群。
- pola-R-CHP 是新诊断阶段已进入讨论的强化/替代方向。
- 分子亚型导向策略包括 cell-of-origin、特定遗传亚型和靶向通路。
- R/R 阶段药物前移是一条主线，包括抗 CD19 抗体、IMiD 类、CAR-T 和 CD20xCD3 双抗。

关键信息

- 作者：Kana Miyazaki。
- 核心价值：把一线治疗、分子分层、免疫治疗前移放在同一张路线图。
- 证据性质：综述，不是新随机试验；适合用于追踪正在形成的一线研究框架。
- 方向标签：pola-R-CHP、tafasitamab、golcadomide、CAR-T、CD20xCD3、frontline DLBCL。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确提及 R-CHOP、pola-R-CHP、分子靶向、tafasitamab、golcadomide、CAR-T 和 CD20xCD3 双抗早线探索。

论文作者观点

论文作者观点：新诊断 DLBCL 治疗正在从统一 R-CHOP 模式走向高危/分子分型下的组合与前移研究。

我的推断

我的推断：未来一线研究需要把高危生物学定义前置，否则新药前移很容易被总体人群稀释。该综述不能替代具体方案的前瞻性验证。

R/R LBCL 证据蓝图：CAR-T、双抗、ADC 和下一代组合的排序难题

From breakthroughs to blueprints: evolving evidence and future directions in relapsed and refractory large B-cell lymphoma.

PMID 41871044

打开 PubMed

R/R LBCL / CAR-T / 双抗 / ADC / 证据框架

复发/难治 large B-cell lymphoma

PDAT/MDAT 命中; 2026-06-11 发表, 近 7 天新增

人群

R/R LBCL 患者, 包括 CAR-T 不适合或 CAR-T 后复发人群

干预/暴露

CAR-T、双抗、ADC、双抗-ADC、双靶 CAR-T 和抗原逃逸规避策略

比较

传统化疗对照、当代 CAR-T 标准和不同治疗序贯

结局

持久缓解、可及性、可解释证据、分子分层和公平获益

结论

这篇 Blood 综述认为 R/R LBCL 治疗格局已由 CAR-T、双抗和 ADC 快速改写, 但证据基础仍滞后于药物创新。随机研究提示 ADC 或双抗锚定方案可优于传统化疗对照; 下一代方向包括双抗-ADC 组合、双靶点 CAR-T 和抗原逃逸规避策略。核心挑战是如何形成可解释、可及、与当代标准对照一致的证据路径。

主要内容

- 综述强调 R/R LBCL 的治疗层级正在被细胞治疗、双抗和 ADC 重塑。
- 作者指出部分随机研究已有优于旧化疗对照的信号, 但地区差异、选择性入组和过时对照影响解释。
- 下一代研究方向包括 bispecific-ADC、dual-target CAR-T 和针对 antigen escape 的方案。
- 证据建设需要当代 CAR-T 标准对照、统一入组标准、前瞻性分子谱和自适应平台试验。

关键信息

- 作者: Manali Kamdar, Nancy L Bartlett。
- 核心价值: 不是单药摘要, 而是 R/R LBCL 后 CAR-T 时代的证据建设框架。
- 覆盖方向: CAR-T、bispecific antibody、ADC、dual-target CAR-T、antigen escape。
- 方向标签: R/R LBCL、evidence infrastructure、sequencing、ADC、bispecific、CAR-T。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要明确描述 R/R LBCL 中 CAR-T、双抗、ADC、双抗-ADC、双靶 CAR-T 和抗原逃逸策略。

论文作者观点

论文作者观点: 治疗创新已快于证据基础建设, 未来需要更合理的对照、分子分层和可演化平台试验。

我的推断

我的推断: 做 R/R LBCL 文献监测时, 不能只按药名分类, 还要记录研究是否有当代对照、是否包含 CAR-T 后人群、是否能回答排序问题。

Double-expressor DLBCL 系统综述：DEL 风险量化与 Z+R-CHOP / Ven-R-CHOP 信号

A systematic evaluation of double-expressor lymphoma: prognostic impact, determinants of outcome, and comparative efficacy and safety of novel therapies.

PMID 42255243

打开 PubMed

DEL / 系统综述 / BTKi 与 BCL2 靶向联合

MYC/BCL2 double-expressor DLBCL

EDAT/MDAT 命中；2026 年记录更新，本轮未重复纳入

P 人群

MYC/BCL2 double-expressor DLBCL 患者

I 干预/暴露

R-CHOP 联合 lenalidomide、BTKi 或 venetoclax 等新方案

C 比较

R-CHOP、DA-EPOCH-R 和多种新药联合方案的系统比较

O 结局

PFS、OS、预后因素、疗效排序和安全性排序

结论

这项两阶段证据综合纳入 66 项研究、9808 例患者，确认 DEL 相比非 DEL 的 PFS 和 OS 均较差；在 13 项治疗研究、1803 例患者的网络荟萃分析中，Z+R-CHOP 和 Ven-R-CHOP 显示最高疗效排序，其中 Z+R-CHOP 的血液学毒性相对有利。作者强调这些信号仍需前瞻性验证。

主要内容

- DEL 定义为 DLBCL 中 MYC 和 BCL2 蛋白共表达。
- DEL 与较差 PFS 和 OS 相关：PFS HR 1.78，OS HR 1.90。
- DEL 内部不良因素包括高 IPI、高龄、LDH 升高、B 症状、晚期和 TP53 突变等。
- 网络荟萃比较 R-CHOP、DA-EPOCH-R、R2-CHOP、I+R-CHOP、Z+R-CHOP 和 Ven-R-CHOP。

关键信息

- 作者：Hao Guan、Zhihe Liu、Chengwen Gao、Wenqiu Wang、Kaiyue Liu、Xia Zhao 等。
- BTKi 覆盖：比较中包含 ibrutinib+R-CHOP 和 zanubrutinib+R-CHOP。
- 核心数据：DEL 的 OS HR 1.90；Z+R-CHOP 和 Ven-R-CHOP 疗效排序靠前。
- 方向标签：double-expressor lymphoma、MYC/BCL2、zanubrutinib、ibrutinib、venetoclax、network meta-analysis。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确报告纳入研究数、患者数、PFS/OS HR、比较方案和 Z+R-CHOP / Ven-R-CHOP 的排序结论。

论文作者观点

论文作者观点：DEL 是可量化的高危亚型，Z+R-CHOP 是值得前瞻性验证的潜在策略。

我的推断

我的推断：DEL 研究应避免把 MYC/BCL2 表达当作单一标签，需要同时记录 TP53、IPI、COO 和毒性。网络荟萃排序不能直接等同于临床优选。

MYD88 L265P：非 GCB/ABC DLBCL 的高特异性分子标志

MYD88L265P mutation is a highly specific marker for the nonGCB/ABC DLBCL molecular subtype.

PMID 42257713

打开 PubMed

分子分型 / MYD88 / ABC DLBCL

DLBCL，特别是 non-GCB / ABC 亚型和结外部位

EDAT/PDAT/MDAT 命中；2026-06-08 发表，近 7 天新增

P 人群

DLBCL 和小 B 细胞淋巴瘤组织样本

I 干预/暴露

FFPE 组织 MYD88 L265P AS-PCR 检测

C 比较

non-GCB vs GCB、结外 vs 非结外部位

O 结局

突变频率、病理表型、COO 分类和结外部位富集

结论

研究基于 FFPE 组织的 AS-PCR 检测 MYD88 L265P，并在 204 例 DLBCL 和 249 例小 B 细胞淋巴瘤中关联病理表型、COO、肿瘤部位和遗传特征。DLBCL 中 MYD88 L265P 发生率为 32%，显著富集于 non-GCB 表型和结外部位，包括免疫豁免部位。作者认为该突变高度特异地标记 non-GCB/ABC DLBCL，并可能反映 MCD/C5 遗传特征。

主要内容

- 研究使用 FFPE 组织和 AS-PCR 进行 MYD88 L265P 检测。
- DLBCL 队列中 MYD88 L265P 阳性率 32%。
- 突变与 non-GCB 表型显著相关，OR 5.78；与结外部位相关，OR 5.44。
- 结外部位包括免疫豁免部位，也包括皮肤、乳腺、上呼吸道、肾上腺、骨和软组织等。

关键信息

- 作者：Lucia Sánchez Magdaleno、Aitana Avendaño Pomares、Patricia Arribas、Víctor Secadas、Santiago Montes Moreno。
- 核心意义：MYD88 L265P 可作为 ABC/non-GCB 与 MCD/C5 生物学的实用病理分型入口。
- 与 CNSL 关联：免疫豁免部位富集提示它也可帮助解释 CNS/睾丸等部位 DLBCL 的分子背景。
- 方向标签：MYD88 L265P、ABC DLBCL、non-GCB、extranodal、MCD/C5。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确报告检测方法、样本量、DLBCL 阳性率、non-GCB 和结外部位相关 OR。

论文作者观点

论文作者观点：MYD88 L265P 是 non-GCB/ABC DLBCL 的高度特异标志，可能代表 MCD/C5 遗传特征的一部分。

我的推断

我的推断：BTK/NF-kB 通路相关研究可把 MYD88 L265P 作为分层变量；但该研究本身不是 BTKi 疗效研究，不能推断突变阳性一定获益。

DLBCL 肿瘤来源 EV 通过巨噬细胞诱导 MDSC 积累和 T 细胞抑制

Tumour-Derived Extracellular Vesicles Induce Diffuse Large B-Cell Lymphoma Progression Through Macrophage-Mediated MDSC Accumulation.

PMID 42269122

打开 PubMed

机制研究 / 免疫微环境 / 耐药与免疫抑制

DLBCL

EDAT/MDAT 命中; 2026-06 发表, 近 7 天记录新增/更新, 本轮未重复纳入

人群

DLBCL 患者样本、细胞和体内模型相关体系

干预/暴露

肿瘤来源 EV、巨噬细胞/MDSC 轴和 metformin 代谢干预

比较

巨噬细胞去除、胆固醇代谢抑制或对照条件

结局

MDSC 浸润、IL-1 β 分泌、T 细胞抑制/耗竭和 EV 分泌

结论

该机制研究显示, DLBCL 肿瘤来源细胞外囊泡可把胆固醇递送给巨噬细胞, 激活 NLRP3/IL-1 β 轴, 导致 IL-1 β 介导的 MDSC 扩增, 并伴随 T 细胞抑制和耗竭。体内外巨噬细胞去除可阻断 EV 诱导的 MDSC 浸润; metformin 抑制胆固醇生物合成后, 可减少 EV 分泌、IL-1 β 和 MDSC 积累。

主要内容

- 研究关注外周 MDSC 升高与 DLBCL 抗肿瘤免疫抑制和不良预后的关联。
- 肿瘤来源 EV 作为信使, 将胆固醇从淋巴瘤细胞递送给巨噬细胞。
- 巨噬细胞经 EV 激活后通过 NLRP3/IL-1 β 轴促进 MDSC 扩增。
- metformin 通过抑制胆固醇代谢降低 EV 分泌, 并减少 IL-1 β 和 MDSC。

关键信息

- 作者: Mengke Liu、YingYu Dong、Qixiao Guan、JianBiao Wang、Qing Shi、RongGui Lin 等。
- 核心机制: DLBCL cell EV -> macrophage cholesterol loading -> NLRP3/IL-1 β -> MDSC expansion -> T cell suppression。
- 研究价值: 把代谢、髓系免疫抑制和 T 细胞耗竭串联到一个可干预机制。
- 方向标签: extracellular vesicles、macrophage、MDSC、NLRP3、IL-1 β 、metformin、immune resistance。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要明确报告 EV、胆固醇递送、巨噬细胞 IL-1 β 、MDSC 扩增、T 细胞抑制和 metformin 干预结果。

论文作者观点

论文作者观点: 肿瘤来源 EV 以巨噬细胞依赖方式诱导 MDSC 积累, 可能被 metformin 通过抑制胆固醇生物合成所靶向。

我的推断

我的推断: 双抗/CAR-T 研究可以考虑同步监测 MDSC、IL-1 β 和 EV 相关指标, 用于解释免疫治疗低反应。该研究仍是机制层面, 不能转化为用药建议。

CNSL 治疗 MDAT 更新: orelabrutinib + rituximab + HD-MTX 回顾研究

Efficacy and safety of orelabrutinib combined with rituximab and high dose methotrexate in primary or secondary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma: a retrospective analysis.

PMID 40450180

打开 PubMed

CNSL / BTKi / orelabrutinib / 回顾研究

原发或继发中枢神经系统 DLBCL

MDAT 命中; MDAT 记录更新, 原始发表日期为 2025 Jun, 不是近 7 天新发表

人群

原发或继发中枢神经系统 DLBCL 患者

干预/暴露

orelabrutinib + rituximab + high-dose methotrexate

比较

rituximab + high-dose methotrexate 历史对照

结局

CR 率、PFS、OS、2 年 OS 和 3-4 级/5 级 AE

结论

这项回顾研究比较 orelabrutinib+rituximab+HD-MTX (ORM) 与 rituximab+HD-MTX (RM) 用于 CNSL。共纳入 32 例, ORM 组 14 例、RM 组 18 例; ORM 组 CR 率 84.6%, RM 组 44.4%; 中位 PFS 为 26.3 vs 18.6 月, OS 在 ORM 组未达到, RM 组 34.1 月; 两组 3-4 级 AE 相近, 未报告 5 级 AE。

主要内容

- 研究对象为原发或继发 CNS diffuse large B-cell lymphoma。
- ORM 组来自 2021-04 至 2023-10, RM 对照来自 2017-06 至 2024-01。
- 疗效信号: CR 84.6% vs 44.4%, P=0.032; 2 年 OS 82.1% vs 57.5%。
- 安全性: 两组未报告 5 级 AE, 3-4 级 AE 发生率相近。

关键信息

- 作者: Jiahao Zhou、Lingxiao Xing、Yi Miao、Shuchao Qin、Run Zhang、Hanning Tang 等。
- 证据边界: 这是 MDAT 更新纳入的既往发表回顾研究, 不是近 7 天新发表临床试验。
- 为何纳入: 它直接覆盖 CNSL、BTKi、HD-MTX 联合和中国中心数据, 是本轮 CNSL 治疗相关性最高的未重复条目。
- 方向标签: CNSL、PCNSL、secondary CNS lymphoma、orelabrutinib、BTKi、high-dose methotrexate。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要明确报告 32 例、ORM/RM 分组、CR、PFS、OS、2 年 OS 和 AE 数据。

论文作者观点

论文作者观点: ORM 方案在 CNSL 中有效且耐受性可接受, 可能为 CNSL 提供新的潜在治疗策略。

我的推断

我的推断: CNSL 新药研究应同时证明 CNS 可达性、与 HD-MTX 骨架的增益和安全性。该研究为回顾性小样本, 不能作为治疗推荐或标准方案结论。

今日综合判断 · 2026-06-14

今日重点不是单个药名，而是 CNS 预防、双抗固定疗程、CAR-T 前处理药代和免疫微环境分层这些可改变研究设计的变量。

已验证证据

本轮官方候选池 284 条，精选 10 篇未重复 PMID：42285113、42285354、42285114、42274643、42286378、41871044、42255243、42257713、42269122、40450180。已验证证据覆盖：一线 epcoritamab 化疗减量/去化疗探索、CAR-T 桥接反应、CAR-T 患者报告症状、CNS 预防社论信号、新诊断 DLBCL 策略综述、R/R LBCL 证据框架、DEL 网络荟萃、MYD88 分型、EV-MDSC 免疫抑制机制，以及 CNSL orelabrutinib+R-HD-MTX 回顾数据。

论文作者观点

论文作者共同指向的方向是：DLBCL 研究正在从单药有效性扩展到人群精细化、治疗负担、桥接/序贯、免疫微环境和分子分型；CNSL 方向则继续围绕 CNS 预防再评价和 BTKi+HD-MTX 骨架优化展开。部分条目为综述、社论或 MDAT 更新，不能与近 7 天原创临床试验混同。

我的推断

我的推断是：近期最值得追踪的研究变量包括一线双抗能否在老年/合并症人群降低治疗负担、CAR-T 前桥接反应能否成为输注前核心质量指标、PRO 能否补足 CAR-T 毒性记录、DEL/MYD88 等分子变量能否用于靶向联合分层、MDSC/EV 轴能否解释免疫治疗低反应、CNSL 中 BTKi 联合是否能在可控毒性下增加 CNS 疾病控制。以上仅用于文献监测和研究设计启示，不构成治疗推荐。

固定本地文件：pubmed-pages/index.html。固定公网链接：<https://zhengyi-pharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>。PubMed 链接均使用 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/\[PMID\]/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/[PMID]/) 格式。